



Collection MedWIZ

3^e année médecine

PSYCHOLOGIE MÉDICALE,
SÉMIOLOGIE GÉNÉRALE
ET
APPAREIL CARDIO-RESPIRATOIRE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Psychologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Abord et examen psychiatrique d'un patient	10				
02	Aspects communicationnels de la rencontre avec le malade et sa famille	12				
03	Stress et maladies psychosomatiques	14				
04	Fonctionnement de la personnalité	16				
05	Examen mental en psychiatrie	18				
06	Psychologie de la douleur	22				
07	Psychologie de la prescription	24				
08	Annonce d'une maladie grave	26				
09	Problèmes particuliers de l'entrevue psychiatrique	28				

II. Sémiologie :

1. Sémiologie générale :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
10	Sémiologie médicale : généralités et sémantique	34				
11	Abord et examen clinique d'un patient	36				
12	Observation médicale	38				
13	Bases du raisonnement clinique	40				
14	Examens complémentaires	42				
15	Oedèmes	44				
16	Déshydratations	46				
17	Sémiologie pondérale	48				

2. Sémiologie cardiaque :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
18	Examen cardiaque	54				
19	Douleurs thoraciques	56				
20	Auscultation cardiaque normale	58				
21	Bruits surajoutés en auscultation cardiaque	60				
22	Souffles	62				
23	Syncopes et lipothymies	64				
24	Syndrome coronarien aigu (SCA)	66				
25	Péricardites	68				
26	Valvulopathies mitrales	70				
27	Valvulopathies aortiques	72				
28	Sémiologie vasculaire	74				
29	Sémiologie vasculaire pathologique	76				
30	Électrocardiogramme (ECG)	78				

3. Sémiologie respiratoire :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
31	Interrogatoire en pneumologie	82				
32	Signes physiques respiratoires	84				
33	Auscultation pulmonaire	86				
34	Douleurs thoraciques, vomique et dysphonie	88				
35	Toux et expectoration	90				
36	Hémoptysie et sifflements	92				
37	Syndromes pulmonaires	94				
38	Syndromes bronchiques	96				
39	Syndromes pleuraux	98				
40	Syndromes médiastinaux	100				
41	Explorations en pneumologie	102				
42	Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)	106				

III. Physiopathologie :

1. Physiopathologie générale :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
43	Troubles hydro-sodés	112				
44	Thermorégulation	114				
45	Dénutrition	116				

2. Physiopathologie cardiaque :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
46	Insuffisance cardiaque aiguë	120				
47	Choc cardiogénique	122				
48	Choc hypovolémique	124				
49	Choc septique	126				
50	Choc anaphylactique	128				
51	Hypertension artérielle	130				

3. Physiopathologie respiratoire :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
52	Troubles de l'hématose	136				
53	Insuffisance respiratoire aiguë (IRA)	138				
54	Œdème aigu du poumon (OAP)	140				
55	Maladie thrombo-embolique	142				

IV. Biochimie :

1. Biochimie générale :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
56	Biochimie de l'homme sain	148				
57	Différentes étapes de l'analyse biochimique	150				

2. Biochimie cardiaque :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
58	Biomarqueurs cardiaques	154				
59	Explorations lipidiques - Athérogénese	156				
60	Stress oxydatif	160				

3. Biochimie respiratoire :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
61	Liquides de ponction	164				

V. Radiologie :

1. Radiologie générale :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
62	Généralités et principes de l'imagerie par rayon X	172				
63	Généralités et principes de l'imagerie par résonance magnétique (IRM)	174				
64	Produits de contraste en imagerie	176				
65	Échographie et écho-doppler	178				

2. Radiologie cardiaque :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
66	Exploration radiologique du cœur et des gros vaisseaux	182				

3. Radiologie respiratoire :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
67	Explorations en imagerie thoracique	188				
68	Syndromes radiologiques thoraciques	190				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Psychologie

© 2026 The WIZ Group. All rights reserved.

ABORD ET EXAMEN PSYCHIATRIQUE D'UN PATIENT

I. PHASES DE L'EXAMEN CLINIQUE

1. Phase descriptive → recherche de signes et symptômes
2. Phase syndromique → regroupement en syndromes
3. Phase diagnostique → trouble psychiatrique (temporalité + environnement)
4. Examen physique → signes physiques, comorbidités, complications, aide au traitement, diagnostic différentiel

II. PRINCIPES D'ATTITUDE

- Écoute attentive / Implication / Discretion et confidentialité
- Regard positif inconditionnel (sans jugement)
- Empathie (percevoir le système interne d'autrui "comme si", sans perdre le "comme si")
- Authenticité / Compétence / Respect / Sentiment de sécurité

III. OBJECTIF

Repérer les signes/symptômes → alliance de qualité → diagnostic → prise en charge adaptée

IV. STRUCTURE DE L'OBSERVATION PSYCHIATRIQUE

- A. Identité : âge, fratrie, origine, domicile, profession, scolarité
- B. Motif d'hospitalisation
- C. Antécédents
 - Personnels : médicaux, chirurgicaux, psychiatriques (hospitalisations/suivi), toxiques (quantité/durée), gynéco-obstétricaux, juridiques
 - Familiaux : médicaux, chirurgicaux, psychiatriques
- D. Biographie : scolarité, puberté, vie sexuelle, vie professionnelle, personnalité, fratrie, relations familiales, vie sociale, capacité à établir des liens durables et stables, intelligence, hygiène, adaptation
- E. Histoire de la maladie

V. TROUBLES ÉVALUÉS

1. Conduites instinctives
2. Conduites sociales
3. Conduites addictives
4. Fonctions supérieures

Pensée / jugement	• Cours : tachypsychie, bradypsychie, barrages, diffiulté • Contenu : idées obsédantes / délirantes / dépressives / phobies • Distorsion : autistique, magique, paralogique, rationalisme morbide • Jugement : facilitation, carence, distorsion
-------------------	--

5. Perception : hallucinations, psychosensorielles, psychiques, absence de subjectivité/sensorialité, syndrome d'automatisme mental
6. Conscience de soi / environnement : vigilance, attention, orientation, hypo / hypervigilance, états crépusculaires / seconds, dépersonnalisation, déréalisation
7. Affects : hyperémotivité, anxiété, inadéquation, dépressive, expansive, indifférence
- G. Examen physique : constantes hémodynamiques, cardiovasculaire, pulmonaire, neurologique

H. Bilan complémentaire

Examens	Objectifs principaux
ECG	Rythme, troubles du rythme, allongement QT
EEG	Activité électrique cérébrale
Ionogramme	Troubles ioniques
NFS	Anémie, infection, anomalies hématologiques
Bilans thyroïdien	Hypo / hyperthyroïdie
Bilan hépatique	Fonction hépatique
Bilan rénal	Fonction rénale, insuffisance
Bilan toxicologique	Substances toxiques, dépistage

VI. CONCLUSION, DISCUSSION & CONDUITE À TENIR

- Reprise des informations pertinentes
- Discussion diagnostique
- Orientation : ambulatoire, hospitalisation libre ou sans consentement

VII. ÉVOLUTION, SURVEILLANCE & PRONOSTIC

- Évolution : comportementale, cognitive, affective, instinctuelle, physique
- Surveillance : constantes (pouls, FR, température), ECG, conscience, transit/miction, alimentation, sommeil, imprégnation NL
- Pronostic : optimiste si → forme clinique accessible, bon insight, bonne adhérence thérapeutique, support socio-familial de qualité